

治疗 HIV 时常见的药物相互作用

许多药物常在药代动力学方面互相起作用,一种药可能改变另一种药的吸收、分布、代谢、或排泄,可能减少其血浆浓度和效果,或者可能增加其血浆浓度和毒性的危险。常见的问题是口服抗酸剂硫糖铝、胆苯烯胺、didanosine 和一些补充的矿物质等使某种药的生物利用度降低。

药物药代动力学互相作用的潜力很大,最常见的是在同时应用有类似毒性的药物时发生

互相作用。

对可产生重要临床意义的药物相互作用,应避免联合用药。其他相互作用大部分具有中等度意义,这种联合应用可以考虑,但应严密监测。将治疗剂量和预防剂量(常常要小得多)加以区别非常重要。

为防止或减少药物潜在的互相作用,应定期检查所有药物治疗法。包括替代疗法和从药店买来的药物。

常见的药代动力学的药物相互作用(彼此作用的药物)

可能的效应	参与的药物(同组内的任何配对)
骨髓抑制	两性霉素 B, 痛痉宁, TMP-SMZ, 抗新生物药, 氨苯砜, 5-氟胞嘧啶, 更昔洛韦 (ganciclovir), 戊烷脒 IV, 乙胺嘧啶, 磺胺嘧啶, TMP, 叠氮胸苷 (zidovudine)
肝毒性	痛痉宁, 红霉素, 氟康唑, 异烟肼, 酮康唑, 扑热息痛, 苯妥英, 吡嗪酰胺, 利福布定, 利福平
低血钙	皮质类固醇, 膦甲酸三钠, 戊烷脒 IV
低血钾	两性霉素 B, 皮质类固醇, 伊曲康唑 (itraconazole)
肾毒性	两性霉素 B, 氨基糖苷类抗生素, 膦甲酸三钠, 戊烷脒 IV
胰腺炎	酒, 皮质类固醇大剂量 TMP-SMZ, didanosine, 戊烷脒, IV, zalcitabine
外周神经病变	didanosine, 乙胺丁醇, 异烟肼, 灭滴灵, 苯妥英, stavudine, 反应停 (thalidomide), 长春新碱, zalcitabine

常见的药代动力学相互作用的药物(严重的具有临床意义的相互作用)

产生影响的药物	受影响的药物	可能的影响
促蛋白合成类固醇	华法令	增加国际正常化比值 (INR)
抗酸制剂 (mylanta, mucaïne), 硫糖铝	azithromycin, 氟喹诺酮类 (fluoroquinolones), indinavir, 异烟肼, 酮康唑, 四环素类 (如强力霉素)	降低口服生物利用度
抗肿瘤制剂 (如博莱霉素)	苯妥英	四环素类使口服生物利用度显著降低
新诺明 (TMP-MSZ)	华法令	降低血清浓度
胆苯烯胺, 其它粘合树脂	皮质类固醇, 扑热息痛, 华法令	增加 INR
氨苯砜	TMP	降低口服利用度
		降低代谢, 增加骨髓毒性

产生影响的药物	受影响的药物	可能的影响
didanosine (ddi)	氟喹诺酮类(如环丙沙星, 诺氟沙星)dapsone, indinavir, 异烟肼, 伊曲康唑, 四环素类(如强力霉素)	降低口服利用度
氟喹诺酮类(如环丙沙星)	茶碱	降低代谢, 增加血清浓度
氟康唑	华法令	增加 INR
	苯妥英	降低代谢, 增加苯妥英毒性(眼球震颤, 脑共济失调)
	利福布定	增加血清浓度
	terfenadine, astemizole	降低代谢, 增加心脏毒性/心律不齐
	华法令	增加 INR
ganciclovir	didanosine	增加血清浓度
H-受体拮抗剂(如甲氟咪胍, famotidine, ranitidine), omeprazole	伊曲康唑, 酮康唑	降低口服生物利用度
异烟肼	卡马西平	增加血液浓度
	皮质类固醇	降低代谢
	苯妥英	增加血清浓度
indinavir	利福布定	增加血清浓度
	cisapride, 丁苯哌丁醇, 苄苯哌咪唑	降低代谢, 增加心脏毒性/心律不齐
伊曲康唑	cisapride	降低代谢, 增加心脏毒性/心律不齐
	丁苯哌丁醇, 苄苯哌咪唑	降低代谢, 增加心脏毒性/心律不齐
	华法令	增加 INR
酮康唑	cisapride, 丁苯哌丁醇, 苄苯哌咪唑	显著降低代谢, 造成心脏毒性和心律不齐, 包括心动过速性心律不齐
	indinavir, ritonavir	增加血清浓度
	华法令	增加 INR
大环内酯类(如红霉素, clarithromycin), azithromycin	卡马西平	显著降低代谢, 增加血清浓度
	丁苯哌丁醇, 苄苯哌咪唑	显著降低代谢造成心脏毒性和心律不齐, 尤其是心动过速性心律不齐
	利福布定	降低代谢, 增加葡萄膜炎危险
	茶碱	降低代谢
	华法令	增加 INR
矿物质(如钙、镁、铁)	氟喹诺酮类, 四环素类	降低口服生物利用度
美散酮	叠氮胸苷	降低代谢, 增加血清浓度
omeprazole	苯妥英	增加血清浓度
苯妥英	皮质类固醇	增加代谢, 丧失效果
	强力霉素	降低血清浓度
	美散酮	降低血清浓度, 不能控制疼痛, 停药的危险
	ritonavir	增加代谢
羧苯磺胺	dapsone, zidovudine, ganciclovir	增加血清浓度
利福布定	皮质类固醇, 伊曲康唑, 酮康唑, 美散酮, 口服避孕药, 苯妥英, 华法令, saquinavir	增加代谢, 丧失效果

产生影响的药物	受影响的药物	可能的影响
利福平	皮质类固醇, 氟康唑, 伊曲康唑, 美散酮, 口服避孕药, 苯妥英, indinavir, ritonavir, saquinavir, zidovudine	增加代谢, 丧失效果
	酮康唑	增加酮康唑的代谢, 降低利福平的血清浓度
ritonavir	华法令	显著降低 INR
	三唑安定, clarithromycin, 安定, 酮康唑, 伊曲康唑, 红霉素, 利福布定, 三环抗抑郁剂(如去甲丙咪嗪)	增加血清浓度
	灭滴灵	双硫醒样反应
	口服避孕药	增加代谢, 丧失效果
	cisapride, 丁苯哌丁醇, 苄苯哌咪唑	降低代谢, 心脏毒性/心律不齐

耿雅江译自 West J Med 164(10):605, May 1996. 雅 德校

· 简 讯 ·

电力线与癌症无关

芬兰研究人员在近期一项研究中得出结论, 由高压线产生的磁场不会使癌症危险增加。

一组由 383 700 名患者参加的全国性研究发现, 生活在高压线 500 米(550 码)范围内的成人与整个人群对比, 癌症发生率没有明显差异。

研究人员说, 此结果明确指出, 居民区内高压线产生的典型磁场与成人患癌症无关。

自 1979 年以来, 公众担心动力线、发射机以及普通家用设备, 如计算机、电视机、电装置、微波炉及蜂窝电话发射的低频电磁场对健康可能有影响。

蒙特利尔 McGill 大学职业卫生部的 Gilles Theriault 博士说, 只有七、八项研究是在高压

线沿线居民中进行的。1994 年 Theriault 研究发现, 磁场与在磁场环境中工作的工人的癌症有关。

对高压线附近居民的研究结果不同: 一些研究发现成人及儿童的白血病增加, 而另一些研究没有发现癌症增加。

这意味着结果有争议, 仍需要对居住在高压线附近的成人做进一步研究。芬兰的首次研究涉及全国范围居住区磁场与成年人癌症的关系, 此研究比以前住宅区研究的规模大得多。他们的研究对弄清此问题起很大作用。

陈 薇译自 AMN 39(43):14, Nov. 1996 张雅德校